

• 案例分析 •

肺结节病死亡法医学鉴定 1 例

王茜¹, 赵枢泉¹, 石青¹, 尹敏¹, 马龙达¹, 童昉², 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030;

2. 上海健康医学院基础医学院生理教研室, 上海 200237)

【关键词】法医病理学; 结节病; 肺中叶综合征; 医疗过失

【中图分类号】D919.4

【文献标识码】C

【文章编号】1001-5728(2023)05-0596-02

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2023.05.024

结节病 (Sarcoidosis) 在我国法医学实践非常少见, 容易导致漏诊及误诊。本单位曾尸检一例“肺中叶综合征”肺切除术后大出血死亡的医疗纠纷案件, 法医病理学检查证实死者患有肺、心、脾等多器官结节病, 参考国内外文献对结节病的病理诊断标准及法医鉴定注意事项报道如下。

1 案例资料

1.1 临床资料

某女, 65 岁。因“间断咳嗽咳痰 1 年”就诊于某三甲医院, 门诊以“右中叶肺不张”收入院。胸部 CT 示: 右肺中叶外侧段不张; 双肺小结节; 右肺炎症 (图 1)。纤维支气管镜检查提示双肺支气管粘膜慢性炎症性改变; 右中间段狭窄。抗酸染色未见结核杆菌。入院 8 d 后在全麻下行胸腔镜下肺部探查 + 右肺中、上叶切除术, 术中见右肺中叶部分肺不张, 叶裂发育不良, 斜裂及水平裂水肿、致密, 中叶支气管周围淋巴结呈冻结状; 上肺静脉回流障碍; 肺动脉质脆。术中因肺动脉干破裂导致大出血 (出血量病历资料记录不详), 出现心跳骤停, 经持续抢救 40 min 后, 循环恢复但呈持续昏迷状态, 术中输注去白悬浮红细胞液 14 U, 血浆 1 800 ml, 冷沉淀 8 U 及 2 个单位血小板, 术后一直处于昏迷状态, 在 ICU 救治 46 d 后突然出现血压下降, 心率减慢至 0 bpm, 血压血氧测不出, 经胸外按压、注射肾上腺素等抢救措施后, 双侧瞳孔散大死亡, 心电监护呈一条直线, 宣布临床死亡。死亡诊断: 肺部感染、

肾功能不全、右肺中叶综合征、高血压病、冠心病。肺切除手术标本病理检查报告: 右肺中叶支气管粘膜上皮息肉样增生, 粘膜肌层增厚, 纤维增生伴慢性炎细胞浸润, 病变符合“肺中叶综合征”。

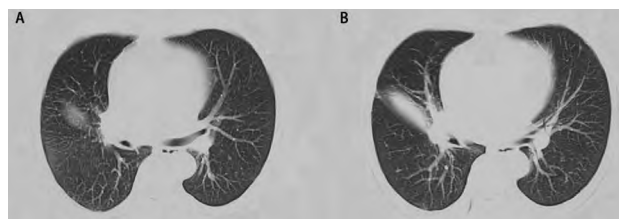


图 1 胸部 CT

A. 右肺炎症; B. 右肺中叶不张。

1.2 法医学检验

解剖检验见脑重 1 230 g, 脑回变宽, 脑沟变浅, 重度脑软化, 额叶蛛网膜下腔片状出血, 桥脑大片状出血。镜下额叶见多发性灶、片状蛛网膜下腔出血, 伴单核、淋巴细胞为主的炎细胞浸润; 脑各部重度软化, 神经元广泛性坏死, 间质细小血管周围可见新旧不一的漏出性出血, 部分细小血管内可见微血栓形成, 脑各部部分细小动脉管壁增厚, 内膜玻璃样变。

右侧胸腔血性积液 700 ml, 左侧胸腔血性积液 160 ml。右肺中上叶缺失, 剩余肺叶表面可见肺大疱形成, 重 410 g, 左肺重 700 g, 左肺与胸壁重度粘连。双侧肺门周围及肺门淋巴结内数量不一的以较多巨噬细胞聚集的肉芽肿结节, 多核巨细胞为主, 周围见成纤维细胞、单核及淋巴细胞浸润; 肺门处脂肪组织内见较多泡沫细胞组成的肉芽肿结节 (图 2)。各肺叶可见少量较肺门肉芽肿小的巨噬细胞聚集的肉芽肿结节, 部分肺组织见散在的多核巨细胞。肺组织抗酸染色结果阴性。

【作者简介】王茜, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学; E-mail: 953321853@qq.com。

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学、法医毒理学教学、检案及研究; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn。

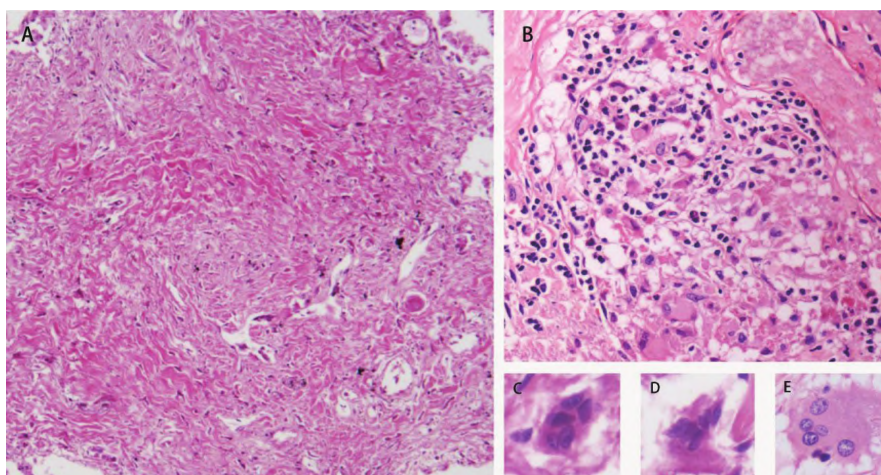


图2 肺门处肉芽肿结节

A. 肺纤维化结节; B. 肺肉芽肿性炎; C-E. 为多核巨细胞
(A.HE×40 B.HE×100 C-E.HE×200)

心包轻度粘连, 心重 420 g, 左心室壁厚 1.4 cm, 心表面及左心室心内膜出血, 冠状动脉左旋支开口处见 4 级孤立性粥样斑块形成。心外膜见较多以巨噬细胞聚集的肉芽肿结节。

脾重 200 g, 脾组织片状纤维化, 见少量肉芽肿结节及多核巨细胞。

法医病理学诊断: 多器官结节病(肺、心、脾); 双侧胸膜腔积液、肺淤血、水肿, 右肺不张并右肺上叶、中叶切除术后; 冠心病; 缺血缺氧性脑病。

死亡原因: 多器官结节病继发右肺中叶肺不张, 在右肺上、中叶切除术中发生急性大出血及急性失血性休克, 导致缺血缺氧性脑病、脑功能障碍致机体健康状况不良, 继发肺炎, 最终多器官功能衰竭死亡。

2 讨论

结节病是一种以非干酪性上皮细胞肉芽肿为病理特征的多系统性、多基因疾病, 目前尚无明确病因^[1]。其发病率为 1~35/10 万人口, 亚裔发病率最低^[2], 该病在我国的发病率未见报道, 但死亡率高达 7.6 %^[3]。在本例中, 患者有咳嗽咳痰 1 年病史, 痰液经抗酸染色检验未见结核杆菌而排除肺结核病。因结节病致肺门淋巴结肿大, 进展为右肺中叶肺不张, 被临床诊为“肺中叶综合征”, 手术治疗导致患者失血性休克死亡的案例。

根据文献报道, 结节病的诊断主要基于三个标准: 相关临床症状和/或放射学表现; 一个或多个组织中存在非坏死性肉芽肿, 以及排除肉芽肿性疾病的其他原因。结节病的一般症状主要为疲劳、发热、体重减轻等, 但其他脏器也可受累, 如肺、心、肝、

脾等, 且会表现不同的临床症状。例如当涉及肺时, 主要表现为呼吸道症状, 包括咳嗽、呼吸困难、胸痛等^[4]。虽然已有诊断标准, 但由于临床症状特异性低及胸部 X 线检查特征不明显, 仅 8.4 % 的患者可以检出, 因此依然容易漏诊误诊。

通过法医尸检及组织病理学检查, 患者肺及肺门、肺门淋巴结见较多典型的以巨噬细胞聚集的肉芽肿结节, 以多核巨细胞为主, 且可见肺纤维化的形成, 心及脾亦见含多核巨细胞及上皮样细胞性的肉芽肿结节。抗酸染色呈阴性, 结合影像学结果及临床症状, 本例是法医病理学实践中较为少见的疾病。

因结节病发病率较低, 发病后无特异性的临床症状, 且须与其他多种临床疾病相鉴别诊断, 故临床诊疗过程中该病常被漏诊或误诊。法医病理诊断及注意事项: (1) 尸体解剖应当注意检查肺门及肺门淋巴结; (2) 病理组织切片, 见结节为非干酪性上皮样细胞肉芽肿, 且无明显坏死, 排除肿瘤结节, 并进行抗酸染色; (3) 实验室辅助检验, 结核抗原检测以及真菌特异性抗体的血清学试验, 排除结核病及真菌感染, 并与其他易混淆的疾病进行鉴别诊断。

参考文献

- [1] Oscar L, Nabeel H. Sarcoidosis[J]. Med Clin N Am, 2019, 103(3): 527-534.
- [2] Patompong U, Jay H R, Eric L M. Clinical manifestations, diagnosis, and treatment of sarcoidosis[J]. Mayo Clin Proc Inn Qual Out, 2019, 3(3): 358-375.
- [3] 张倩, 黄慧, 徐作军. 肺结节病的诊治进展 [J]. 临床内科杂志, 2020, 37(10): 684-688.
- [4] Sève P, Pacheco Y, Durupt F, et al. A clinical overview from symptoms to diagnosis[J]. Cells, 2021, 10(4): 766.

(收稿日期: 2022-09-11)